

Fecha Última Actualización: 30-01-2026 14:43:22

Página 1 de 2

Información Paciente

Nombre : Luis Marcos Zacarías Salvo Pérez	Rut : 8.570.333-1	N° Archivo : 1131325	N° Epicrisis : 470566
Edad : 66a 8m 9d	Fecha Nacto : 21/05/1959	Sexo : Masculino	
Dirección : Pje. Puerto Aysen 3779 Andes Del Sur	Comuna : Puente Alto	Teléfono : 9 7533 5408	

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Intermedio Quirúrgico	Fecha Ingreso : 26/01/2026 15:12	Días Estadía : 4
Unidad de Egreso : Cirugía Sector A - Alta Complejidad	Fecha Egreso : 30/01/2026 14:01	

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Fiebre, ictericia y dolor abdominal

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

COLANGITIS - 27/01/2026 00:00 - Dr.(a) ALEJANDRO IGNACIO BRAÑES GARCÍA

Epidemiología

Resumen Clínico

Antecedentes

* Mórbidos: THO por DHC HCC 21/07/22 (tacro 2-3, AA, cotri, aciclovir). Viñuela. Cava-cava L-L. Porta T-T. AHD-AHP. VB T-T, ligero mismatch

* Medicamentos:

* Qx:

31/05/19 Reseccion no anatómica de tumor pediculado de 2cm, segmento 2. RHP HCC

19/06/20 TACE 16/09 (lesiones V, VII, VIII)

21/07/22 THO por DHC HCC

09/12/22 Hepatectomía lateral izq

CPRES x estenosis vía biliar

- 2023: 14/06, 11/10 (3 prótesis)

- 2024: 07/03 (4 prótesis), 11/07, 28/11

- 2025: 12/02 (retiro de 3 prótesis) con estenosis persistente y VB tortuosa, quedo con 3 prótesis

- 2025: 17/03 derivación BD - Coledocoduodeno.

Historia Clínica

Paciente con antecedente de Trasplante hepático por hepatocarcinoma (2022) + estenosis de VB con manejos frustros a ERCP, en Marzo/25 se realiza derivación biliodigestiva -> Coledocoduodeno.

Acude a urgencias por cuadro de dolor abdominal en flanco derecho de 2 días de evolución asociado a náuseas, vómitos, tos y expectoración además de peak febril hasta 40° en domicilio. A su ingreso destaca, taquicárdico, PAM >80, taquipnea FR 30 rpm, llene capilar <5seg, frío a distal, mottling 5.

TC 26/01: Injerto hepático de tamaño y morfología dentro de límites normales, sin cambios. No presenta lesiones focales sospechosas. Eje venoso porto-espleno-mesentérico y venas suprahepáticas permeables. Varices periesplénicas y gastroesplénicas. Arteria hepática común y sus ramas permeables. Marcada neumobilia de predominio izquierdo, con dilatación de la vía biliar intrahepática y extrahepática, esta última alcanzando un calibre de hasta 21 mm asociado a engrosamiento y

Fecha Epicrisis : 30/01/2026 14:43

Página 1 de 2

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 16:20

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 30-01-2026 14:43:22

Página 2 de 2

mayor realce parietal.

26/01 BT:4.15 BD:2.2 FA:232 GGT:960 GOT:234 GPT:240 INR:1.33 TTPK 23.4 Calcio:10.1 Alb:4.6 Láctico:11.6 Crea:1.32
BUN:22.6 Lipasa:25 PCR:159.8
GDV pH:7.06 HCO3:24.2 pCO2:86.0 pO2:1 4.7 BE-6 Hb:16.6 Leu:14510 Neu:74% Plaq:274.000
HC periférico E. COLI.

Se decide hospitalización en contexto de colangitis secundaria a obstrucción de anastomosis colédoco duodenodo; se realiza endoscopia el 27/01; identificando la coledocoduodeno anastomosis en la cara anterior, con múltiples cálculos y barro biliar en su interior, además de salida de bilipus. La anastomosis se encontraba permeable, sin lesiones. Extracción de multiples calculos de vía biliar, sin litiasis residual.

Evoluciona favorablemente, sin dolor, sin nauseas, sin fiebre, se decide mantener tratamiento antibiótico dado HC (+) y hallazgos, logra descenso de parámetros inflamatorios sin conflictos.

Dado evolución satisfactoria, se decide alta médica con seguimiento ambulatorio y antibiótico vía oral.

Diagnóstico de Egreso

TRANSPLANTE DE HÍGADO -
SEPSIS, NO ESPECIFICADA -
CALCULO DE CONDUCTO BILIAR CON COLANGITIS -

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

Buena tolerancia oral hemodinamia estbale, sin conflictos, sin leucocitosis, PCR en descenso

Plan Post Alta

Indicaciones
Reposo Relativo
Régimen liviano a tolerancia

Tacrolimus 3 mg vo cada 12 horas por 30 días
Acido Ursodesoxicolico 500mg vo c/12hrs por 30 días
Ciprofloxacino 500mg vol cada 12 horas por 7 días
Omeprazol 20mg vo c/24hrs por 15 días

Cita con Dr Rolando Rebolledo en CDT de Trasplante hepático en UNA SEMANA con laboratorios: Solicitar hora al +56225764924, Jazmin Herrera (Lunes a Jueves de 8:30 a 16:30 y Viernes de 8:30 a 16:00 hrs)

Acudir a urgencias en caso de fiebre, dolor abdominal que no cede, nauseas, vómitos, piel amarilla.

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Liviano

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Constanza Quezada Sepúlveda
Becado/Residente

Tamara Ailee Alvarez Veliz
Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 30/01/2026 14:43

Página 2 de 2

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 16:20

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar